

פגיעות בטן

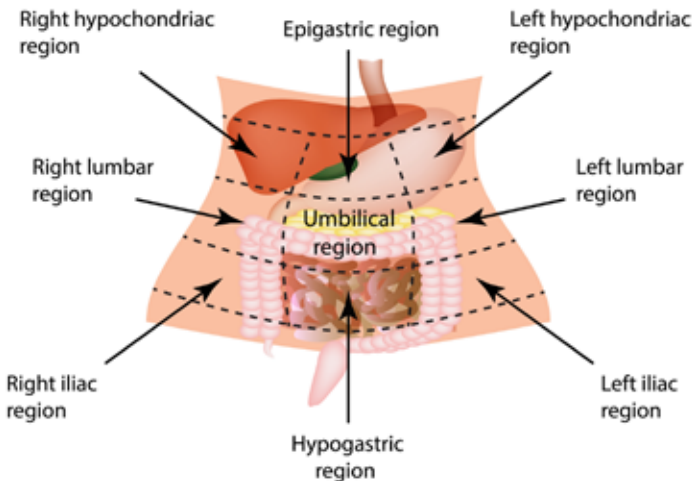
בפגיעות בטן יש כמה בעיות שחשוב לתת עליהן את הדעת. האחת, קשה לאבחן את הפציעה ואת רמת חומרתה. השנייה, בדימום תוך־בטני אין כל אפשרות לעצור את מקור הדימום בשטח אלא רק בחדר הניתוח. פגיעות בטן עלולות לגרום לעיתים קרובות לדימום תוך־בטני נרחב מכיוון שחלל הבטן הוא חלל גדול ובעל יכולת התרחבות רבה, ולכן דימום תוך־בטני יכול לגרום להלם תת־נפחי. נוסף על כך, הפגיעה הבטנית יכולה להיות משולבת גם עם פגיעות חזה מסכנות חיים בגלל הקרבה האנטומית בין שני אזורי הגוף האלה.

מבנה הבטן

הגבול העליון של הבטן הוא קו הפטמות. יש איברים, כגון הכבד והטחול, שמכוסים על ידי כלוב הצלעות, ולכן יש להתייחס לקו הפטמות כגבול העליון. האגן הוא הגבול התחתון. הגבול האחורי הוא עמוד השדרה והשרירים הגביים, והגבול הקדמי הוא שרירי דופן הבטן.

על פי הגדרה זו, הבטן תופסת שטח גדול מאוד מכל הגוף, לכן במרבית פגיעות הטראומה מעורבת פגיעת בטן. הבטן היא חלל שמכיל איברים רבים המוגנים על ידי דופן הבטן. נהוג לחלק את הבטן לארבעה רבעים (איור 7.6):

- רביע שמאלי תחתון (LLQ) - המעי הדק, המעי הגס היורד, הסיגמה, הרחם, השחלות והחצוצרות
- רביע ימני תחתון (RLQ) - המעי העולה, המעי הדק, התוספתן, התריסריון, הרחם, השחלות והחצוצרות
- רביע שמאלי עליון (LUQ) - הקיבה, הטחול, זנב הלב, חלק מהמעי הגס והכליה השמאלית
- רבע ימני עליון (RUQ) - הכבד, כיס המרה, ראש הלב, התריסריון, חלק מהמעי הגס והכליה הימנית



איור 7.6 חלוקה אנטומית של הבטן

בתמונה רואים את חלוקת שטח הבטן לארבעה רבעים ואת האיברים שנמצאים בכל רביע.

סוגי פגיעות בטן

פגיעת בטן יכולה להיות קשה, חודרת והיא יכולה להיגרם בגלל גל הדף לאחר פיצוץ.

פגיעה חודרת - פגיעה זו בדרך כלל נראית לעין. יכולה להיגרם בגלל קליע של רובה או אקדח. פגיעה כזו יכולה לגרום לא רק לפגיעה במקום החדירה של הכדור, אלא בכל הרקמה שמסביב לאזור החדירה וגם בפנים הבטן בשל האנרגיה הרבה מגל ההדף שהכדור יוצר. דקירת סכין היא פגיעה מקומית, אך גם היא יכולה להסב נזק רב לאיברים פנימיים באזור הדקירה. הנזק תלוי בגודל הסכין ובאורכה.

פיצוץ - חלק מפגיעת הדף. פגיעה זו מוכרת בעיקר מזירות פיגועים. גל ההדף שנוצר מפיצוץ פוגע באיברים הפנימיים שבבטן ויכול לגרום לנזק רב ללא כל סימן חיצוני. גם הטלת הגוף למרחק בעקבות הפיצוץ וההדף ופיזור רסיסים יכולים לפגוע בגוף.

חבלה קשה - עלולה להיגרם בשל חבטה ישירה, כגון נפילה מגובה רב, מכת אגרוף, תאונת דרכים, מעיכה נגד חפץ קשה או גל הדף חזק. במקרים אלו יש עלייה פתאומית של הלחץ התוך־בטני שפוגע באיברי הבטן הפנימיים, בייחוד באיברים החלולים שיש בתוכם אוויר, וכמו כן ייתכן קרע של האיבר, כמו בפגיעת הדף.

פגיעות בטן נחשבות לחמורות בגלל האיברים החיוניים שבתוכה. כמעט בכל איברי הבטן יש כמויות גדולות של דם בכל רגע נתון, נוסף על כלי דם גדולים (אבי העורקים הבטני וכן וריד נבוב תחתון) העוברים בחלל הבטן. בדרך כלל לחלל הבטן אין הגנה גרמית (חוץ מהאיברים המוגנים חלקית על ידי הצלעות התחתונות או עצמות האגן), ולכן האיברים חשופים לפגיעות. בתוך איברים מסוימים יש תכולה שיכולה להזיק לשאר הגוף אם יש פגיעה, למשל חומצה בקיבה, חיידקים במעי הגס, רעלים בכבד, שתן בכליות ובשלפוחית. כמו כן, יש להביא בחשבון שהחלק התחתון של עמוד השדרה עלול להיפגע.

כל פגיעת בטן חשודה כמדממת ומזהמת עד לבדיקה בבית חולים.

שכיחות פגיעות חבלות בטן קהות

- טחול הוא האיבר הנפגע בשכיחות הגבוהה ביותר בחבלה מסוג זה: 40%-55%
- הכבד הוא האיבר השני בשכיחותו בפגיעות קהות: 35%-45%
- איברים רטרופריטוניאליים, כולל הלב: 15%
- מעיים - שיעור קטן יותר

שכיחות פגיעות חבלות בטן חודרות

- ירייה
 - מעי דק - 50%
 - מעי גס - 40%
 - כבד - 30%
 - כלי דם גדולים - 25%
- דקירות
 - כבד - 40%
 - מעי דק - 30%
 - מעי גס - 25%
 - סרעפת - 20%

אבחון וטיפול

אבחנת פגיעות בטן היא על בסיס בדיקה והתמונה הקלינית (הקליניקה) בלבד. יש לזכור שבחבלות בטן יכול להיות כלי דם גדול מדמם, וחלון ההזדמנויות לאבחנה ולטיפול הוא צר.

האבחנה כוללת בדיקה גופנית יסודית וחיפוש אחר הסימנים האלה:

- בודקים אם יש אייציבות המודינמית וסימני הלם
- מחפשים סימני גירוי צפקי שיתבטאו בבטן חריפה (תמונה 7.7). בשטח אנו לא מבצעים בדיקת בטן מלאה, אלא בודקים רק אם קיימת רגישות, או בטן קשיחה.
- בודקים את מצב ההכרה - דינאמי
- בשל חשש לפגיעה בעמוד השדרה עושים בדיקה נוירולוגית
- מחפשים אם יש פגיעות נוספות: חבלות באגן, פגיעות ראש או חזה וכדומה.

• מחפשים על הנפגע סימנים חיצוניים בולטים לעין:

- חבורות בטניות
- המטומה סביב אזור הלב
- פצעים
- חפצים תקועים
- דימום רקטלי
- צואה דמית
- שתן דמי
- הקאות דמיות
- יש לשים לב לתנוחה שבה שוכב הנפגע.

תמונה 7.7 בדיקת הבטן

בדיקת הבטן על ידי לחיצות באזורים שונים. כשעולה חשד לפגיעת בטן יש לצפות למצוא בטן קשה המעידה על תכולת דם. כמו כן, יש לצפות לבטן חריפה, כלומר כל נגיעה קלה בבטן תפיק תגובת כאב עז של הנפגע בגלל גירוי קרום הצפק הפגוע.



הטיפול בפגיעות בטן

- 1) מעריכים פגיעות אפשריות לפי סיפור המקרה ומנגנון הפגיעה
- 2) מאבטחים נתיב אוויר ומספקים חמצן בריכוז גבוה במידת הצורך, מתחילים בהחייאה
- 3) מנטרים כל הזמן מצב המודינמי - מחפשים התפתחות סימני הלא
- 4) אם יש חשש לפגיעה בעמוד שדרה - מקבעים ללוח גב
- 5) מחפשים סימנים לדימום פנימי (הקאות או הפרשות דמיות וכדומה)
- 6) מחפשים פגיעות נוספות (ראש, חזה, אגן)
- 7) מכסים איברים הבולטים החוצה מתוך הגוף בפדים רטובים סטריליים (משתמשים בסליין)
- 8) בשום אופן אין לשלוף או להזיז חפצים הנעוצים בבטן
- 9) מפנים בדחיפות לבית חולים
- 10) העברת דיווח לבית חולים על חשד לפגיעת בטן, במטרה לקצר את זמן ההערכות לקבלתו בבית חולים